HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV

Avdelningen för vårdvetenskap

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter

Empirisk studie med kvalitativ ansats

Julia Metsomäki

2026

Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen), 15 hp
Omvårdnad
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård
Examensarbete inom intensivvårdssjuksköterskans kunskapsområde

Handledare: Maria Randmaa
Examinator: Kati Knudsen

Sammanfattning

Bakgrund: Intensivvård ges till patienter med akut eller förvärrad svikt i ett eller flera organsystem. Smärta är vanligt förekommande inom intensivvården och stor andel av patienterna som vårdas inom intensivvården upplever måttlig till svår smärta. Otillräcklig smärtbehandling kan få både korta och långsiktiga konsekvenser. Trots kännedomen om detta föreligger det brister i både bedömning och behandling av smärta på grund av patientens begränsade förmåga att kommunicera.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter.

Metod: Studien har kvalitativ ansats med deskriptiv design. Fem individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in datamaterial. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter presenteras i fyra huvudkategorier: *Att bedöma smärta, variation i användning av strukturerade arbetssätt, utbildning och klinisk erfarenhet* samt *att ha förutsättningar för behandling av smärta.*

Slutsats: Bedömning av smärta hos sederade respiratorvårdade patienter är komplext och svårt. Otillräcklig följsamhet till riktlinjer, rutiner och bedömningsinstrument i klinisk praxis medför att bedömningen i hög grad baseras på erfarenhet, anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck hos patienten. Intensivvårdssjuksköterskorna upplever däremot att det finns ett välfungerande interprofessionellt samarbete, vilket skapar goda förutsättningar till att behandla smärta och på så sätt tillgodose patientens behov.

Nyckelord: Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska; Mekaniskt ventilerad; Sedering; Smärtbedömning; Smärtbehandling

Abstract

Background: Intensive care is provided to patients with acute or deteriorated failure of one or multiple organ systems. Pain is common in the intensive care setting, and a large number of patients admitted to intensive care experience moderate to severe pain. Inadequate pain management may result in both short- and long-term consequences. Despite awareness of this, deficiencies in both pain assessment and pain management persist due to patients limited ability to communicate.

Aim: The aim of the study was to describe intensive care nurses' experiences of assessing and managing pain in sedated, mechanically ventilated patients.

Method: The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Five individual semi-structured interviews were conducted to collect data. The data were analyzed using qualitative content analysis.

Results: Intensive care nurses experiences of assessing and managing pain in sedated, mechanically ventilated patients are presented in four categories: *Assessing pain, variation in the use of structured approaches, education and clinical experience* and *having prerequisites for pain management.*

Conclusion: Pain assessment in sedated, mechanically ventilated patients appears to be complex and challenging. Insufficient adheres to guidelines and pain assessment instruments in clinical practice results in assessment being largely based on clinical experience, medical history, physiological indicators and patients' observable expressions. However, intensive care nurses perceive that there is a well-functioning interprofessional collaboration, which create favorable conditions for pain management and thereby contributes to meeting patient's needs.

Keywords: Intensive care; Intensive care nurse; Mechanically ventilated; Sedation; Pain assessment; Pain management

Innehållsförteckning

1.0 Introduktion 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Intensivvårdssjuksköterskans roll och ansvar 1

1.3 Personcentrerad vård 2

1.4 Respiratorvård och sedering 2

1.5 Smärta 3

1.6 Bedöma och behandla smärta 4

1.7 Teoretisk referensram 4

1.8 Problemformulering 5

1.9 Syfte 5

2.0 Metod 5

2.1 Design 5

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 6

2.3 Datainsamlingsmetod 6

2.4 Tillvägagångsätt 7

2.5 Dataanalys 7

2.6 Forsknings- och forskaretiska överväganden 9

3.0 Resultat 10

3.1 Att bedöma smärta 10

3.1.1 Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck 11

3.1.2 Komplexitet i bedömning 11

3.2 Variation i användning av strukturerade arbetssätt 12

3.2.1 Att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner 12

3.2.2 Att tillämpa eller inte tillämpa bedömningsinstrument 12

3.3 Utbildning och klinisk erfarenhet 13

3.3.1 Att ha varierande utbildningsnivå 13

3.3.2 Att ha klinisk erfarenhet 14

3.4 Att ha förutsättningar för behandling av smärta 14

4.0 Diskussion 15

4.1 Huvudresultat 15

4.2 Resultatdiskussion 15

4.3 Metoddiskussion 19

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 21

4.5 Förslag till fortsatt forskning 21

4.6 Slutsats 22

4.7 Användning av generativ AI 22

5.0 Referenser 22

1.0 Introduktion

1.1 Bakgrund

Intensivvård ges till patienter med akut eller förvärrad svikt i ett eller flera organsystem. Vården kan omfatta organstödjande, organbevarande eller organersättande behandling. Intensivvården kännetecknas av avancerad övervakning i en högteknologisk miljö med invasiva behandlingsmetoder. För att kunna upprätthålla och möjliggöra denna vårdnivå krävs ett multidisciplinärt arbete med hög kompetensnivå och specialistutbildad personal (Svensk förening för Anestesi & Intensivvård 2024). Smärta är vanligt förekommande inom intensivvården och det uppskattas att mellan 40–77% av patienterna som vårdas inom intensivvården upplever måttlig till svår smärta, oavsett den primära inläggningsorsaken (Bhattacharyya, Laycock, Brett, Beatty & Kemp 2024). Otillräcklig smärtbehandling kan få både korta och långsiktiga konsekvenser, inklusive fysiologiska stressreaktioner samt negativa psykologiska effekter som posttraumatiska symtom, ångest och försämrad livskvalitet (Bhattacharyya et al. 2024; Laycock, Ward, Halmshaw, Nagy & Bantel 2013). Trots kännedom om detta föreligger det brister i både bedömning och behandling av smärta på grund av patientens begränsade förmåga att kommunicera till följd av sedering och respiratorvård. Med hänsyn till detta drabbas en betydande andel av intensivvårdspatienterna av underbehandlad smärta (Hamdan, Shaheen & Abdalrahim 2022; Almutairi et al. 2022).

1.2 Intensivvårdssjuksköterskans roll och ansvar

Kompetensbeskrivningen Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2021) beskriver att intensivvårdssjuksköterskans roll innefattar ett arbete i högteknologisk miljö med komplexa och avancerade omvårdnadssituationer. Intensivvårdssjuksköterskan ska i den komplexa vårdmiljön kunna bedöma, identifiera, utvärdera och utföra relevanta åtgärder baserat på den enskilda patientens situation och tillstånd, utifrån detta också ha beredskap och tillhandahålla resurser för oväntade händelser som kan uppstå vid kritisk sjukdom. Intensivvårdssjuksköterskan ska förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande, detta genom att bedriva vård baserat på ett personcentrerat arbetssätt, inte bara gentemot patienten utan även emot deras närstående (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2021).

1.3 Personcentrerad vård

Det saknas en entydig och allmän definition av personcentrerad vård. Enligt Edberg, Ehrenberg, Wijk och Öhlén (2013) kan personcentrerad vård emellertid förstås genom fyra kärnbegrepp: Att känna sig själv, att vara i en relation, att vara i en social värd och att vara på en plats. Den personcentrerade vården understryker respekten för den enskilda individen genom kritisk realistisk personalism där patienten, tillsammans med sina närstående utgör den primära utgångspunkten för vårdens organisering. Detta innebär ett skifte från en traditionell medicinsk strukturerad omvårdnad mot ett partnerskap mellan vårdpersonal, patient och närstående som grundar sig i ömsesidig respekt och omtanke (Edberg et al. 2013).

Inom intensivvården återspeglas detta genom ett arbetssätt där kompetenser från olika professioner inom omvårdnad, rehabilitering och medicin integreras och anpassas efter patientens individuella behov. Intensivvårdssjuksköterskan har ett särskilt ansvar att tillämpa och främja ett personcentrerat förhållningssätt i den högteknologiska vårdmiljön. Detta genom att värna för patientens autonomi, värdighet, integritet och delaktighet under hela vårdförloppet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2021). Eftersom många kritiskt sjuka patienter saknar förmåga att själva kommunicera kan det vara svårt att som intensivvårdssjuksköterska upprätthålla patientens individuella önskemål och värderingar, därför är involvering av närstående en central del i den personcentrerade vården (Secunda & Kruser 2022).

1.4 Respiratorvård och sedering

Respiratorvård används för att upprätthålla en tillräcklig ventilation och syresättning. Inom intensivvården är detta vanligt förekommande och är i många fall en livsavgörande åtgärd vid kritisk sjukdom (Rubulotta et al. 2024). Vid behov av respiratorvård förs en endotrakealtub ner i luftvägen, antingen via näsan eller munnen (Gulbrandsen & Stubberud 2009). Enligt Sharma, Hashmi och Valentino (2024) upplever patienter ofta smärta i samband med respiratorvård. Vilket kan relateras till både närvaron av endotrakealtuben och påfrestningen som den mekaniska ventilationen innebär (Sharma, Hashmi & Valentino 2024). För att minska patientens lidande och möjliggöra tolerans av behandlingen används sedering i kombination med smärtstillande läkemedel (Temesgen et al. 2021; Boncyk et al. 2024).

Sedering definieras enligt Gulbrandsen och Stubberud (2009) som en farmakologiskt inducerad reduktion av det centrala nervsystemets aktivitet med syfte att sänka medvetandegraden och uppnå lugnande effekt. Sedering kan förekomma i olika nivåer, där lätt sedering ofta resulterar i dåsighet medan djup sedering kan leda till ett tillstånd som motsvarar djupsömn. De flesta respiratorvårdade patienter är i behov av någon grad av sedering, inte enbart på grund av obehaget från endotrakealtuben och den mekaniska ventilationen utan också på grund av att intensivvårdsmiljön kan upplevas som både skrämmande och stressframkallande (Gulbrandsen & Stubberud 2009). Sederingsnivån kan däremot variera mellan patienter och bör utvärderas och omprövas regelbundet utifrån individuella behov (Gulbrandsen & Stubberud 2009; Boncyk et al. 2024).

1.5 Smärta

Smärta är en komplex fysiologisk och sensorisk upplevelse som har till syfte att skydda kroppen mot faktisk eller potentiell vävnadsskada. Smärta är subjektivt och upplevelsen av smärtan skiljer sig därför mellan enskilda individer (Nordness, Hayhurst & Pandharipande 2021). Kritisk sjuka som kräver respiratorvård upplever smärta av varierande intensitet. Smärtan är inte enbart relaterad till den mekaniska ventilationen, som i sig kan upplevas obehaglig, utan även till diagnostiska och omvårdnadsrelaterade ingrepp som är nödvändiga för att säkerställa rätt vårdplan (Pota et al. 2022). Utöver detta kan patienter som vårdas inom intensivvården uppleva smärta även i vila utan påfrestningar av pågående ingrepp och yttre stimuli (Nazari, Froelicher, Nia, Hajihosseini & Mousazadeh 2022). En otillräcklig och obehandlad smärta kan medföra ett flertal allvarliga komplikationer, inklusive förlängd vårdtid, längre tid i respirator, nedsatt immunförsvar, ökad syrgasförbrukning samt utveckling av hypermetabola tillstånd. Därtill kan underbehandlad smärta även bidra till psykologiska besvär som posttraumatisk stress, ångest och akuta stressreaktioner. Det finns även ett samband mellan otillräcklig smärtlindring och ökad risk för utveckling av långvarig smärta, vilket på sikt kan ge försämrad livskvalitet hos patienten (Pota et al. 2022; Nazari et al. 2022; Kress, Pohlman & Hall 2002). Trots vetskapen om konsekvenserna av underbehandlad smärta föreligger det brister i smärthanteringen förknippat med patientens begränsade förmåga att kommunicera (Hamdan Shaheen & Abdalrahim 2022; Almutairi et al. 2022).

1.6 Bedöma och behandla smärta

Kommunikation är ett grundläggande redskap i samspelet mellan människor och likaså mellan patient och sjuksköterska. Alla patienter har rätt till att uttrycka sina åsikter och behov oberoende av kommunikationsförmåga. Vid respiratorvård inom intensivvården begränsas förmågan att uttrycka sig verbalt vilket inte bara kan skapa sårbarhet men även frustration och stresstillstånd hos patienten (Johnson, Heyns & Nilsson 2022; Talebi et al. 2025). Det här ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan som måste vara närvarande och lyhörd för att kunna bedöma och behandla exempelvis smärta när patienten inte själv kan kommunicera verbalt (Johnson, Heyns & Nilsson 2022).

Det finns flera validerade bedömningsinstrument att tillgå för bedöma smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. De vanligaste och mest tillförlitliga att använda hos patienter som inte kan kommunicera är Critical Care Pain Observation Tool (CCPOT) (Wojnar-Gruszka et al. 2022; Nürnberg Damström, Saboonchi, Sackey & Björling 2011). CCPOT omfattar fyra områden: Patientens ansiktsuttryck, kroppsrörelser, följsamhet i respirator samt muskeltonus. Varje område har en poängskala mellan 0–2 poäng, vilket ger en total poängsumma mellan 0 och 8. För att få en så rättvis bedömning som möjligt ska CCPOT användas när patienten befinner sig i vila. Instrumentet kan även användas innan och efter administrering av smärtlindring för att möjliggöra en systematisk utvärdering av behandlingseffekten (Maatouk, Al Tassi, Fawaz & Itani 2019; Vårdhandboken 2024).

1.7 Teoretisk referensram

Huvudområdet omvårdnad grundar sig i fyra bärande begrepp. Hälsa, människa, miljö och vårdande (Edberg & Wijk 2019). Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskriver *människan* som en individ med grundläggande och unika behov. De huvudsakliga behoven är till stor del av samma karaktär hos människan, men de tillgodoses utifrån individuella och unika förhållanden. Alla människor har rätt till att uttrycka sig kring sina behov och sjuksköterskan har en central roll i att identifiera dessa och genomföra relevanta omvårdnadsåtgärder. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan lära känna sin patient och skapa en relation som gör att en värdering av patientens tankar, känslor och reaktioner kan förstås och utvärderas. Patienten måste också förstås i sitt livssammanhang varför Henderson också inkluderar familjemedlemmar som en källa till information. Enligt Henderson syftar *vårdande* till

att minska lidande, bevara värdighet och stödja återhämtning och självständighet. Om tillfrisknande inte är möjligt, bidra till en fridfull död (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012). Då patienterna är sederade vid respiratorvård och oförmögna att varken kommunicera eller agera självständigt är sjuksköterskans förmåga att identifiera individuella behov och utföra lämplig behandling en förutsättning för god *hälsa* (Johnson, Heyns & Nilsson 2022; Talebi et al. 2025). Med hänsyn till detta har Hendersons omvårdnadsteori om att tillfredsställa behov används som utgångpunkt i studien (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012)

1.8 Problemformulering

Smärta är vanligt förekommande inom intensivvården och en betydande andel av patienterna som vårdas inom intensivvården upplever måttlig till svår smärta. Trots att det är väldokumenterad kring konsekvenserna av otillräcklig smärtbehandling föreligger det brister i både bedömning och behandling av smärta hos denna patientgrupp. Dessa brister är i stor utsträckning relaterade till patientens begränsade förmåga att kommunicera sin smärtupplevelse till följd av respiratorvård och sedering. Intensivvårdssjuksköterskan har ett centralt ansvar i att identifiera, bedöma och behandla smärta i den högteknologiska och komplexa vårdmiljön som intensivvården bidrar till. Mot bakgrund av intensivvårdssjuksköterskors professionella ansvar och den personcentrerade vårdens principer finns ett behov av en fördjupad kunskap kring hur intensivvårdssjuksköterskor upplever arbetet med att bedöma och behandla smärta hos denna patientgrupp. En ökad förståelse kan utgöra underlag för utveckling och utbildning kring både riktlinjer och omvårdnadsstrategier.

1.9 Syfte

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter.

2.0 Metod

2.1 Design

Föreliggande studie har en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Vilket enligt Polit och Beck (2021) är en passande design när man strävar efter att få en djupare förståelse för komplexa frågor och redogöra för enskilda upplevelser.

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Ett bekvämlighetsurval tillämpades som urvalsmetod. Urvalsmetoden är tidseffektiv och innebär att de mest tillgängliga deltagarna inkluderas i studien (Polit & Beck 2021). Studien genomfördes på en allmän intensivvårdsavdelning i Mellansverige. Avdelningen omfattas av sex intensivvårdsplatser och bedriver vård för samtliga åldersgrupper. På avdelningen är cirka 40–50 intensivvårdssjuksköterskor verksamma. Fem intensivvårdssjuksköterskor inkluderades i studien. Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor, den yngsta var 31 år och den äldsta 38 år (medianålder 34 år). Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet inom yrket varierade mellan 1,5 år och 13 år (medianvärde 4 år). Inget bortfall uppkom under studien.

Inklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård, oberoende av erfarenhet inom yrket, i syfte att möjliggöra variation i deltagargruppen. Exklusionskriterier var sjuksköterskor verksamma på intensivvårdsavdelningen utan specialistsjuksköterskeexamen, intensivvårdssjuksköterskor med övervägande administrativa uppgifter och intensivvårdssjuksköterskor utan tillsvidareanställning. Då de sannolikt inte har kunnat etablera sig tillräckligt i avdelningens riktlinjer och rutiner.

2.3 Datainsamlingsmetod

Fem individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data. Det här är en lämplig metod att använda då det enligt Polit och Beck (2021) ger ingående och detaljrik information. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide som utarbetades med utgångspunkt i studiens syfte. Intervjuguiden bidrog till ett enhetligt genomförande genom att samtliga deltagare fick samma frågor. Det här minskade risken för variation i datainsamlingen och bidrog till att stärka studiens tillförlitlighet och giltighet (Polit & Beck 2021). Intervjuguiden bestod av inledande frågor som involverade demografisk data såsom kön, ålder samt erfarenhet inom yrket. Intervjuguiden innefattade även ytterligare fyra öppna frågor som i huvuddrag beskrev upplevelsen av bedömning och behandling av smärta hos sederade respiratorvårdade patienter, med följdfrågor som *”kan du utveckla”* och *”kan du berätta/beskriva mer”* för att kunna få ut mer djupgående svar. För att kunna identifiera eventuella otydligheter samt testa intervjuguidens lämplighet gentemot syftet genomfördes en provintervju,

vilket också stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2021). Provintervjun bedömdes tillämpbar och den inkluderades därför i studien.

2.4 Tillvägagångsätt

Ett rådgivande yttrande ansöktes till forskningsetiska rådet på högskolan i Gävle (FER). Efter att rådgivande yttrande hade godtagits skickades en ansökan till berörd verksamhetschef på intensivvårdsavdelningen i Mellansverige gällande tillåtelse att genomföra studien. I ansökan fanns information om studiens syfte samt hur studien skulle genomföras. Verksamhetschefen gav sitt godkännande till att genomföra studien. Författaren hade sedan tidigare mejllista till intensivvårdssjuksköterskorna på grund av aktiv anställning på berörd intensivvårdsavdelning. Vårdenhetschefer informerades därför om studien och godtog att denna mejllista användes för att rekrytera deltagare till studien. Informationsbrev skickades ut via mejl till alla intensivvårdssjuksköterskor på avdelningen. De första fem som visade intresse och uppfyllde kriterierna involverades i studien. Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte och ett skriftligt samtycke inhämtades från deltagarna vid intervjutillfället. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen i ett avskilt rum, valt av deltagarna. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Den kortaste intervjun varade i 4 minuter och den längsta 8 minuter (medianvärde 6 minuter) och genomfördes under november månad 2025 av en författare. Materialet avidentifierades, kodades och förvarades avskilt så att ingen utomstående kunde ta del av det.

2.5 Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) tillämpades i analys av data. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant av författaren. De transkriberade materialet lästes sedan noggrant flera gånger för att få en helhetsbild kring innehållet, detta för att öka studiens trovärdigheten (Polit & Beck 2021). Texten delades sedan in i meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till kortare textstycken. Slutligen delades textstyckena upp i koder som beskrev innehållet. Koderna delades i sin tur in i huvudkategorier och subkategorier beroende på likheter och skillnader, inget material exkluderades (Graneheim & Lundman 2004). För att minska risken för feltolkningar och för att stärka studiens trovärdighet fokuserade analysen på det manifesta innehållet i datamaterialet. Analys av manifest innehåll innebär, till skillnad

från latent innehåll som avser den underliggande tolkningen av materialet, ett fokus på det uttalande och konkreta innehållet. Analysen hölls därmed textnära utan egen tolkning (Graneheim & Lundman 2004). Det insamlade materialet diskuterades även gemensamt i handledningsgruppen för att stärka studiens tillförlitligheten och trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck 2021). Exempel på dataanalysen visas i *tabell 1*.

Tabell 1. *Exempel på dataanalysen*

Meningsbärande enheter	Kondensering	Kod	Subkategori	Kategori
”Nej det tycker jag inte, Nej inte så här som, det finns säkert liksom rutin men inte som praktiseras. Det blir lite individuell vård, för jag vet ju inte om alla gör lika som jag gör, sen kan det ju dock bli en diskussion om det men det skulle ju vara önskvärt med mer standaliserat liksom”.	Nej det tycker jag inte, finns säkert en rutin men inte som praktiseras. Det blir individuell vård för jag vet inte om alla gör lika som jag. Det kan bli en diskussion om det men det skulle vara önskvärt med mer standaliserat.	Individuell vård då inga rutiner följs eller praktiseras.	Att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner	Variation i användning av strukturerade arbetssätt
”Alltså mest på kanske puls och blodtryck, även på smärta sen tidigare men också ansiktsuttryck, typ hur dem rör sig i sängen om dem kvider sig, ligger och liksom drar sig, det är svårt”.	Främst på puls, blodtryck, smärta sedan tidigare samt ansiktsuttryck och hur dem rör sig i sängen, om dem kvider sig och drar sig. Det är svårt.	Vitala parametrar, ansiktsuttryck samt anamnes och hur dem rör sig.	Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck	Att bedöma smärta
”Ja det är supersvårt eftersom dem inte kan uttrycka vad dem känner eftersom att dem inte kan prata. Det är alltid svårt, det blir ju en objektiv bedömning och inte någonting subjektiv som smärta är ju en subjektiv sak”.	Ja det är svårt eftersom dem inte kan uttrycka vad dem känner då dem inte kan prata. Det blir en objektiv bedömning på en subjektiv sak.	Svårt då dem inte kan uttrycka sig eller prata. Blir en objektiv bedömning.	Komplexitet i bedömning	Att bedöma smärta

2.6 Forsknings- och forskaretiska överväganden

Vetenskapsrådet (2024) uppger fyra principer i sin kodex som ska tillämpas inom forskningsetik för att kunna främja god forskningsed. Tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. Tillförlitlighet innebär att kvaliteten på forskningen kan säkerställas genom design, metod och analys. Detta tillämpades genom att kontinuerlig grupphandledningen skedde under hela processen, materialet diskuterades gemensamt med andra studerande och handledare vilket stärker tillförlitligheten. Ärlighet har upprätthållits genom att forskningen genomförts rättvist och objektivt under hela processen, från genomförande till granskning och sammanställning. Författarens förståelse för valt fenomen har under processen åsidosatts till största mån för att inte ha inverkan på resultatet. Deltagarna fick själva välja plats för utförande av intervjuerna och fick information om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst under processen, detta för att upprätthålla respekt för deltagare, kollegor och miljö. Ansvar grundar sig i att författaren själv tog ansvar för forskningen, från idé till publicering. Om det uppstod konsekvenser har författaren själv tagit ansvar för detta (Vetenskapsrådet 2024).

Författaren hade också samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav i beaktande. För att kunna ta hänsyn till samtyckeskravet fick deltagarna i studien fylla i en samtyckesblankett innan intervjun. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte. Deltagarna informerades även om att medverkan var helt frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas när som helst utan krav på motivering. För att möjliggöra detta tillhandahölls kontaktuppgifter till författaren. Dessa åtgärder vidtogs i syfte att uppfylla informationskravet. Forskningsfrågan bedömdes inte vara av känslig karaktär eller sannolikt väcka starka känslor hos deltagarna, om en känslig situation trots detta hade uppstått informerades deltagarna om möjligheten till att pausa eller avbryta sitt deltagande. Gällande konfidentialitetskravet har inga känsliga personuppgifter använts vid redovisning av resultat. Resultatet har också redovisats på gruppnivå för att ingen enskild individ skulle kunna identifieras. Endast författare och handledare hade tillgång till datamaterialet efter att det transkriberats och datamaterialet har bevarats på Högskolan i Gävles databas som ingen utomstående har kunnat tagit del av. Allt datamaterial har också att förstörts efter godkänt och publicerat arbete. Med hänseende till nyttjandekravet har åtaganden som

nämnts av deltagarna endast användas i ändamål för aktuell studie (Vetenskapsrådet 2024).

3.0 Resultat

Resultatet framställs utifrån syftet: Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. Analysprocessen av intervjuerna resulterade i fyra huvudkategorier: *Att bedöma smärta, variation i användning av strukturerade arbetssätt, utbildning och klinisk erfarenhet* samt *att ha förutsättningar för behandling av smärta.* Samt sex subkategorier: *Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck*, *komplexitet i bedömning, att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner, att tillämpa eller inte tillämpa bedömningsinstrument, att ha varierande utbildningsnivå* samt *att ha klinisk erfarenhet.* Översikt av kategorier och subkategorier ses i *tabell 2*. Resultatet presenteras i löpande text och förstärks med citat från intervjuerna. För att bibehålla konfidentialiteten benämns intensivvårdssjuksköterskorna som *informant* med efterföljande siffra *1–5*.

Tabell 2. *Kategorier och subkategorier*

Kategori	Subkategori
Att bedöma smärta	- Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck - Komplexitet i bedömning
Variation i användning av strukturerade arbetssätt	- Att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner - Att tillämpa eller inte tillämpa bedömningsinstrument
Utbildning och klinisk erfarenhet	- Att ha varierande utbildningsnivå - Att ha klinisk erfarenhet
Att ha förutsättningar för behandling av smärta	

3.1 Att bedöma smärta

I denna kategori beskrivs intensivvårdssjuksköterskornas tillvägagångssätt för att bedöma smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. Kategorin omfattar två subkategorier: *Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck* och *komplexitet i bedömning*.

3.1.1 Anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck

Smärtbedömning hos sederade respiratorvårdade patienter beskrevs som en process där flera informationskällor integrerades. Smärta bedömdes främst genom fysiologiska indikationer, såsom förändringar och variationer i blodtryck och puls. Särskilt om de vitala parametrarna inte kunde härledas till någon annan tydlig orsak. Patienternas beteendemässiga uttryck beskrevs också användas i bedömningen av smärta, vilket omfattade både ansiktsuttryck och hur de uttryckte sig via kroppsspråk. Exempel på detta var om de rynkade pannan, grinade illa eller kved i sängen i samband med omvårdnadsåtgärder eller lägesändringar. Utöver detta framhölls även anamnes som en central del av smärtbedömningen. Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att de ofta utgick från vad som var förväntat utifrån patientens inläggningsorsak, bakgrundssjukdomar och om de hade någon smärtproblematik sedan tidigare.

”Alltså mest på kanske puls och blodtryck, även på smärta sen tidigare men också ansiktsuttryck, typ hur dom rör sig i sängen om dom kvider sig, ligger och liksom drar sig, det är svårt”. (Informant 3)

3.1.2 Komplexitet i bedömning

Smärtbedömning hos sederade respiratorvårdade patienter upplevdes som svårt och komplext hos intensivvårdssjuksköterskorna. Utmaningen var huvudsakligen patienternas begränsade förmåga att uttrycka sig verbalt kring sin smärta, vilket medförde att bedömningen i hög grad baserades på intensivvårdssjuksköterskornas egna tolkningar. Detta upplevdes som problematiskt, då bedömningen riskerades att påverkas av personliga värderingar och känslor vilket gjorde att bedömningen upplevdes som mindre tillförlitlig. Vidare betonades det att det var svårt att särskilja smärta från oro och att sederingen kunde bli ett hinder i bedömningsprocessen. Det framkom även att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att sedering ofta prioriterades i första hand istället för att öka eller ge mer smärtlindring. Det betonades också att även om man kan förvänta sig en viss typ av smärta hos en patient är upplevelsen av smärta alltid individuell, vilket bidrog till osäkerhet i bedömningen.

”Ja det är super svårt eftersom att dom inte kan uttrycka vad dom känner eftersom att dom inte kan prata. Det är alltid svårt, det blir ju en objektiv bedömning och inte nånting subjektiv som smärta är”. (Informant 5)

3.2 Variation i användning av strukturerade arbetssätt

Denna kategori beskriver intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser kring användning av riktlinjer, rutiner och strukturerade bedömningsinstrument. Kategorin omfattar två subkategorier: *Att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner* samt *att tillämpa eller inte tillämpa bedömningsinstrument.*

3.2.1 Att inte använda etablerade riktlinjer och rutiner

Avsaknad av tydliga riktlinjer och rutiner kring hur smärta ska bedömas hos sederade respiratorvårdade patienter framträdde som en återkommande problematik. Det nämndes att det visserligen fanns rutiner men att dessa inte tillämpades konsekvent i den kliniska praktiken. Detta relaterades till bristande följsamhet i det dagliga arbetet. Smärta ingick i vissa fall i den neurologiska genomgången under ronden, men denna beskrevs inte genomföras systematiskt och vissa aspekter riskerades att förbises. Detta kopplades bland annat till antagandet att patienterna redan erhöll smärtlindring i samband med sedering. Vidare betonades det att brist på följsamhet till riktlinjer kunde bidra till ojämlik vård, då bedömningen och handläggningen varierade mellan intensivvårdssjuksköterskorna. En ökad grad av standarlisering efterfrågades därför för att främja en mer likvärdig och strukturerad smärtbedömning.

”Nej det tycker jag inte, Nej inte så här som, det finns säkert liksom rutin men inte som praktiseras. Det blir lite individuell vård, för jag vet ju inte om alla gör lika som jag gör”. (Informant 1)

3.2.2 Att tillämpa eller inte tillämpa bedömningsinstrument

Vid bedömning av smärta hos sederade respiratorvårdade patienter tillämpades inte bedömningsinstrument. Bedömningsinstrument beskrevs främst användas i situationer där patienterna vad lätt sederade och kunde kommunicera genom att exempelvis nicka eller peka. Samtidigt framkom en medvetenhet om att strukturerade bedömningsinstrument fanns tillgängliga och kunde användas som stöd i smärtbedömningen hos denna patientgrupp, men dessa tillämpades inte konsekvent i praktiken. Detta relaterades till upplevelsen om att personalen på avdelningen genrellt hade bristande följsamhet kring användning av bedömningsinstrument, vilket ansågs minska dess värde när de inte användes enhetligt. Arbetsbelastning lyftes även fram av intensivvårdssjuksköterskorna som en faktor som begränsade möjligheten till att

genomföra strukturerade bedömningar. Vidare beskrevs även bedömningsinstrumenten som svåra att tillämpa i klinisk praxis.

”Ja, och sen kulturen på avdelningen, det är nog inte ens alla som vet var CPOT är. Det försvårar ju också, det ger ingen effekt även om jag skulle göra de så rapporterar jag det vidare och den som jag rapporterar till vet inte ens vad siffran betyder”. (Informant 5)

3.3 Utbildning och klinisk erfarenhet

Denna kategori beskriver intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av utbildning, kunskap och klinisk erfarenhet i relation till smärthantering hos sederade respiratorvårdade patienter. Kategorin omfattar två subkategorier: *Att ha varierande utbildningsnivå* och *att ha klinisk erfarenhet.*

3.3.1 Att ha varierande utbildningsnivå

Upplevelsen kring kunskap och utbildning inom smärtbedömning och smärtbehandling varierade mellan intensivvårdssjuksköterskorna. De intensivvårdssjuksköterskor med mer klinisk erfarenhet upplevde att de hade tillräckligt med kunskap och utbildning gällande bedömning och behandling av smärta. Samtidigt framkom det att den befintliga kunskapen inte alltid omsattes i praktiken. De intensivvårdssjuksköterskor med mindre klinisk erfarenhet upplevde att det fanns utrymme för mer kunskap och utbildning för att möjliggöra en mer enhetlig och strukturerad smärtbedömning. Det framkom en efterfrågan på utbildning i användning av smärtbedömningsinstrument och andra hjälpmedel, tydligare riktlinjer att arbeta utifrån samt fördjupad kunskap kring smärta i sin helhet.

”Kunskapen finns nog där men jag kanske inte alltid tillämpar den”. (Informant 2)

”Kan alltid bli bättre tänker jag, finns säkert jättebra redskap man kan använda också som man inte använder”. (Informant 3)

3.3.2 Att ha klinisk erfarenhet

Klinisk erfarenhet och professionell trygghet beskrevs som grundläggande i både bedömning och behandling av smärta. Erfarenhet och den kliniska blicken framträdde som centrala resurser i smärtbedömningsprocessen. Det framkom även att ökad trygghet och erfarenhet bidrog till att intensivvårdssjuksköterskorna i högre grad vågade agera utifrån sin bedömning och stå upp för patienten och föra dess talan, exempelvis när tecken på smärta identifierades.

”Ja jag tror absolut erfarenhet och lite trygghet i sig själv att våga stå på sig för patienten, patienten kan inte tala för sig”. (Informant 2)

3.4 Att ha förutsättningar för behandling av smärta

Förutsättningarna för att ge adekvat smärtlindring när smärta identifierats upplevdes som goda. Samarbete och kommunikation med ansvariga läkare upplevdes som välfungerade, där läkarna upplevdes som lyhörda i frågor som rörde smärtlindring. Det framkom även att smärtbehandling ofta möjliggjordes genom att patienterna hade pågående infusioner av smärtstillande läkemedel, vilka intensivvårdssjuksköterskorna själva kunde justera vid tecken på smärta. Därtill fanns generella ordinationer tillgängliga som kunde användas vid behov, vilket upplevdes underlätta en snabb och flexibel smärtbehandling.

”Ja jag tycker att jag får gehör om jag märker att en patient har ont, det är ju framförallt på den här avdelningen man kan ge lite, det är ju ingen liksom risk för patienten på det sättet att man kan hamnar i en farlig situation med att ge för mycket om du förstår vad jag menar”. (Informant 4)

4.0 Diskussion

4.1 Huvudresultat

I föreliggande studie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter framkom fyra huvudkategorier: *Att bedöma smärta, variation i användning av strukturerade arbetssätt, utbildning och klinisk erfarenhet* samt *att ha förutsättningar för behandling av smärta.*

4.2 Resultatdiskussion

Det framkom från intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie att de vanligaste tillvägagångsättet att bedöma smärta hos sederade respiratorvårdade patienter var genom att observera förändringar i vitala parametrar. Särskilt i de fall där förändringarna inte kunde härledas till någon annan tydlig orsak. Detta stöds av Thomas, Kuruppasseril, Samad och George (2025) som beskriver att smärta kan utlösa stressreaktioner som visar sig i form av fysiologiska reaktioner. Vilka kan yttra sig genom förhöjt blodtryck, takykardi, svettningar och pupilldilatation. Sådana fysiologiska förändringar kan indikera förekomst av smärta hos kritiska sjuka patienter som saknar möjligheten till att kommunicera verbalt. I studien nämns en ökning i både blodtryck och puls i samband med smärtsamma ingrepp. Däremot understryker författarna att bedömning av smärta enbart baserat på vitala parametrar har begränsad tillförlitlighet (Thomas et al 2025). Flera studier visar på att vitalparametrar inte ensamt kan ge en fullständig bild kring smärtupplevelsen hos patienten. Det finns begränsat med vetenskapligt stöd för dess giltighet som metod för smärtbedöming (Arbour & Gélinas 2010; Nordness, Hayhurst & Pandharipande 2021; Kress, Pohlman & Hall 2002; Shahiri & Gélinas 2023). Det beror bland annat på grund av att vitala parametrar kan påverkas av en rad andra faktorer som egentligen inte är direkt relaterade till smärta. Såsom underliggande sjukdomstillstånd inklusive cirkulationssvikt och sepsis samt behandling med exempelvis vasoaktiva läkemedel, sederande och lugnande läkemedel samt betablockerare. Mot denna bakgrund bör bedömning av smärta baserat på vitala parametrar göras med försiktighet. Om vitala parametrar används ska detta göras i kombination med andra strukturerade bedömningsmetoder för att få en mer noggrann och tillförlitlig smärtbedömning (Yaman Gülper, Reisli, Arıcan, Yosunkaya & Tuncer Uzun 2023; Thomas et al. 2025)

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev även att de bedömde smärta hos sederade respiratorvårdade patienter utifrån beteendemässiga uttryck, både ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Det här överensstämmer med tidigare forskning där grimarsering, rynkade ögonbryn och kroppsrörelser beskrivs som beteendeparametrar som kan indikera smärtupplevelser hos patienten (Yaman Gülper et al. 2023; Herr, Coyne, McCaffery, Manworren & Merkel 2011). Dessa uttryck kan ses som alternativa kommunikationssätt hos patienter som saknar förmåga att verbalt förmedla obehag och smärta, exempelvis till följd av respiratorvård och sedering (Yaman Gülper et al. 2023; Herr et al. 2011). Förmågan att tolka och uppmärksamma sådana uttryck kan vidare relateras till Hendersons omvårdadsteori. Där sjuksköterskans förmåga att kunna förstå reaktioner och uttryck från patienten är en förutsättning för att kunna identifiera och tillgodose behov hos patienten (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012).

Det framgick tydligt att bedömningsinstrument inte tillämpades för att bedöma smärta hos sederade respiratorvårdade patienter bland intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en bristande följsamhet till bedömningsinstrument på avdelningen vilket upplevdes minska instrumentets effektivitet. De upplevde också att arbetsbelastningen var ett hinder för regelbunden användning samt att instrumenten var svåra att använda i klinisk praxis. Att inte tillämpa bedömningsinstrument står i konstrast mot tidigare forskning som uppger att noggrann smärtbedömning med lämpliga instrument är det mest grundläggande för att kunna ge effektiv smärtbehandling hos patienter som inte verbalt kan uttrycka sig kring sin upplevelse av smärta (Nazari et al. 2022; Buttes, Keal, Cronin, Stocks & Stout 2014). Däremot betonar Danel et al. (2025) att exempelvis bedömningsinstrumentet CPOT bör kombineras med andra former av klinisk bedömning. Såsom fysiologiska parametrar och beteendemässiga uttryck från patienten. Detta motiveras utifrån att instrumentets tillförlitlighet kan vara begränsad hos djupt sederade patienter samt hos patienter med nedsatt neurologisk förmåga och förlamning (Danel et al. 2025). Samtidigt beskrev Azevedo-Santos och DeSantana (2018) att CPOT upplevs som tidsparande, lättbegripligt och kliniskt användbart hos intensivvårdssjuksköterskor (Azevedo-Santos & DeSantana 2018). Detta står i konstrast till intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse i föreliggande studie som beskrev instrumenten som svåra att tillämpa i klinisk praxis. Däremot överensstämmer intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av hög arbetsbelastning som ett hinder för

strukturerad smärtbedömning med tidigare forskning. Alotni et al. (2023) och Deldar Froutan och Ebadi (2018) nämner att personalbrist och hög arbetsbelastning är ett hinder för att systematiskt och effektivt kunna bedöma och hantera smärta hos intensivvårdspatienter.

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev en gemensam upplevelse av att smärtbedömning hos sederade respiratorvårdade patienter är både svårt och komplext. Detta relaterades främst till patienternas begränsade möjlighet till att verbalt uttrycka sin smärtupplevelse. Liknande upplevelser är beskrivet i aktuell forskning. Där smärtbedömning hos icke-kommunicerbara patienter till följd av sedering och respiratorvård framhålls som särskilt utmanande (Correya, Rawson, Ockerby & Hutchinson 2025; Danel et al. 2025). Vidare framkom det i föreliggande studie att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde svårigheter med att särskilja smärta från oro och att sederande läkemedel användes som förstahandsåtgärd. Snarare än att initiera eller optimera smärtlindring. Överadministrering av sederande läkemedel är enligt Kress, Pohlman och Hall (2002) ett vanligt förekommande fenomen inom intensivvården då smärta också kan uttrycka sig som ångest och agitation. Dessa uttryck riskerar att tolkas som primär oro snarare än tecken på obehandlad smärta. Sambandet mellan ångest och smärta i samband med intensivvård och kritisk sjukdom belyses även av Docherty et. al. (2023) som beskrev att ångest och smärta ofta samexisterar (Kress, Pohlman & Hall 2002; Docherty et al. 2023). Vidare nämner Kress, Pohlman och Hall (2002) att sederande läkemedel däremot inte bör användas som ersättning för adekvat smärtlindring, utan att en individuell planering kring smärtbehandling bör prioriteras i första hand. Vidare beskrevs det att en välfungerande smärtbehandlingsstrategi kan bidra med minskat behov av sederande läkemedel hos denna patientgrupp. Samtidigt betonas vikten av omvärdering av strategin då patients tillstånd och behov kan förändras över tid. Författarna påpekar däremot även att ångest kan förekomma trots adekvat smärtlindring och att en sederingsstrategi också alltid bör finnas tillgängligt (Kress, Pohlman & Hall 2002). Överadministrering av sederande läkemedel är också associerat med flera komplikationer. Dessa inkluderar bland annat förlängd vårdtid, längre tid i respirator samt förhöjd risk för utveckling av delirium, vilket bör tas i beaktande vid sedering- och smärtstrategier (Sharma, Hashmi & Valentino 2024). Hanteringen av smärta och ångest i ett sammantaget perspektiv kan även relateras till Hendersons omvårdadsteori där vikten av att se hela människan understryks. Henderson inkluderar

fysiska, psykiska och sociala aspekter i omvårdnadsarbetet (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012).

Kunskap och utbildningsnivå varierade mellan intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie. De intensivvårdssjuksköterskor med mindre klinisk erfarenhet upplevde att mer kunskap och utbildning skulle vara hjälpsamt för att mer strukturerat bedöma smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. Henderson uppger att forskningsbaserad kunskap är en central komponent i omvårdnadsarbetet och att sjuksköterskan i nutid förväntas vara en mer självständig del i teamet, till skillnad från tidigare när sjuksköterskan helt baserade sin omvårdnad utifrån ordinationer från läkare (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012). Efterfrågan av mer kunskap och utbildning bland intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie kan sättas i relation med tidigare forskning. Shuaib (2018) uppger att det är viktigt att som sjuksköterska vara utrustad med aktuell kunskap för att kunna bedöma och hantera smärta hos intensivvårdspatienter. Detta överensstämmer med Hamadeh, Lambert, Willetts och Garvey (2024) som understryker att det ligger i sjuksköterskans professionella ansvar att vara aktiv i att inhämta och upprätthålla kunskap avseende smärtbedömning och behandling. Samtidigt nämns det också att det övergripande ansvaret vilar på organisationen i stort. Organisationen bör prioritera och tillhandahålla utbildning gällande smärta för att kunna upprätthålla kvaliteten på vården. Dessutom se till att protokoll och hjälpsamma verktyg finns tillgängliga och uppmuntra till följsamhet till riktlinjer (Hamadeh et al. 2024). Avsaknad av följsamhet till etablerade riktlinjer och rutiner framkom som ett återkommande problem bland intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie. De upplevde att variationer i hur smärtbedömningen genomfördes medförde att vården i hög grad blev beroende av vilken intensivvårdssjuksköterska som var i tjänst. Detta uppfattades kunna leda till ojämlik vård.
Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde därför att en ökad grad av standardisering avseende smärtbedömning skulle vara gynnsamt, i syfte att säkerställa jämlik och konsekvent vård där alla patienter erbjuds likvärdig bedömning. Vidare framkommer det i tidigare studier att rätt utbildning och förmågan att korrekt kunna bedöma och behandla smärta är avgörande för patientens upplevelse av intensivvården (Hamadeh et al. 2024; Jamal et al. 2023). Kortare vårdtider, minskad tid i respirator samt lägre krav på sedering är även det positiva följder av tillfredsställande smärtbehandling (Hamadeh et al. 2024; Kress, Pohlman & Hall 2002).

Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de hade goda förutsättningar för att kunna behandla smärta hos patienterna. Detta möjliggjordes genom ett välfungerande samarbete och en god kommunikation med läkare i frågor som rörde smärtlindring. Ett välfungerande teamarbete beskrivs av Weller, Mahajan, Fahey-Williams och Webster (2024) som en grundläggande faktor för att stärka och upprätthålla patientsäkerhet samt för att kunna skapa en gemensam förståelse kring patientens tillstånd och behov. Författarna betonade också vikten av att alla i personalen oavsett profession är villiga till att bidra med observationer och att det finns en arbetsmiljö som tillåter inkludering i beslutsfattandet kring patienten (Weller et al. 2024). Detta kan även relateras till personcentrerad vård, där kompetenser från olika professioner integreras och anpassas efter patientens individuella behov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2021). Betydelsen av interprofessionellt samarbete framhålls även i Hendersons omvårdnadsteori, där samarbete mellan vårdprofessioner ses som en förutsättning för att kunna tillgodose patientens grundläggande behov (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012). Gulbrandsen och Stubberud (2009) beskriver att hjälplöshet är en förekommande känsla hos intensivvårdspatienter då de ofta saknar möjlighet att kontrollera sin situation. Vidare framkommer det också att upplevelsen av obehag och smärta kan minska när patienten upplever viss grad av kontroll, vilket kan vara svårt att uppnå i en intensivvårdssmiljö (Gulbrandsen & Stubberud 2009). Enligt Hendersons teori har sjuksköterskan en central roll i att stötta patienten i detta, att vara en samarbetspartner tills oberoende kan uppnås (Wiklund-Gustin & Lindwall 2012). Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att klinisk erfarenhet var en viktig förutsättning för att kunna tillgodose patientens behov av smärtlindring. Erfarenheten bidrog till ökad trygghet i yrkesrollen och till att våga framföra och stå fast vid patientens behov i frågor som rörde smärtlindring och smärtbehandling.

4.3 Metoddiskussion

Syftet med föreliggande studie var att redogöra för intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. För att besvara syftet tillämpades en kvalitativ ansats med deskriptiv design, vilket är lämpligt när målet är att beskriva och ge en fördjupat förståelse av erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck 2021). Deltagarna i studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket möjliggjorde inkludering av de mest tillgängliga deltagarna

och var tidsmässigt mest genomförbart. En svaghet och begränsning med denna urvalsmetod är att det kan bli bristande variation mellan deltagare, vilket kan påverka studiens överförbarhet samt möjlighet till att generalisera resultatet till en större population. Däremot är föreliggande studie utformad för att förklara och beskriva upplevelsen av ett fenomen, varför urvalet ses som tillämpbart gentemot studiens syfte (Polit & Beck 2021). En annan svaghet i föreliggande studie är att det fanns liten variation i ålder bland undersökningsgruppen samt att det saknades könsfördelning, då alla deltagare var kvinnor. Däremot är sjuksköterskeyrket kvinnodominerat vilket kan ha haft betydelse för urvalet. Samtidigt fanns större variation mellan deltagarna gällande erfarenhet inom yrket som intensivvårdssjuksköterska. Graneheim och Lundman (2004) uppgav att detta styrker studiens trovärdighet då syftet kan belysas från flera aspekter. Endast fem informanter intervjuades vilket kan ses som en svaghet då andra potentiella deltagare förbisågs som hade kunnat ge mer variation och spridning i deltagargruppen. Däremot har detta arbete genomförts på egen hand av en författare, varför antalet informanter ansetts tillräckligt inom ramen för detta examensarbete.

Individuella semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, detta för att tillåta och uppmuntra deltagarna att med egna ord dela med sig om sina upplevelser. En intervjuguide skapades utifrån studiens syfte och en provintervju genomfördes för att testa dess lämplighet gentemot syftet. Provintervjun ansågs lämplig varför denna användes i studiens resultat. Detta bidrog med att öka studiens trovärdighet (Polit & Beck 2021). Insamlingen av data skedde även under en begränsad tidsperiod vilket stärker studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2021). Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer vilket kan ses som en svaghet med studien. Intervjuerna var relativt korta vilket kan ses som ytterligare en begränsning. Trots detta bedömdes mättnad ha uppnåtts efter fem intervjuer då inga nya perspektiv framfördes. Graneheim och Lundman (2004) uppgav att mängden data kan variera beroende på komplexiteten i forskningsfrågan och att trovärdighet ändå kan uppnås trots mindre mängd datamaterial (Graneheim & Lundman 2004).

I analys av data tillämpades kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). All insamlad data transkriberades ordagrant och lästes igenom och bearbetades flera gånger för att få en helhetsbild kring innehållet. Därefter analyserades materialet stegvis enligt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Det kan ses

som en svaghet att materialet hanterades av endast en författare, men för att öka tillförlitligheten och trovärdighet diskuterades de gemensamt med andra studenter i handledningsgruppen och ihop med handledare för att minimera risken för feltolkningar och för att minska risken för färgning av resultatet (Polit & Beck 2021). Vidare så har författaren sedan tidigare erfarenhet av intensivvård och varit medveten om att det finns en viss förförståelse och har haft detta i beaktande under processen. För att stärka trovärdigheten har resultatet styrkts med citat från informanterna (Graneheim & Lundman 2004).

Forskningsetiska överväganden togs i beaktande under processen enligt Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 2024). Informanterna erhöll både skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt om att deltagandet var helt frivilligt. Deltagarna fick även välja tid och plats själva för intervjuerna och skriva under skriftligt samtycke innan intervjuerna genomfördes. För att bibehålla och säkerställa konfidentialitet kodades materialet från intervjuerna och förvarades så att ingen utomstående kunde ta del av det. Författaren hade sedan tidigare en arbetsrelation med intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i studien vilket togs i beaktande då detta skulle kunna påverka trovärdigheten. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevdes däremot vara bekväma och ärliga under intervjuerna trots relationen med författaren.

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad

Studien kan bidra till en ökad medvetenhet hos specialistsjuksköterskor avseende bedömning och behandling av smärta hos sederade respiratorvårdade patienter. Smärta utgör en central del av vården och chanserna till en optimal återhämtning efter intensivvård ökar avsevärd om adekvat smärtlindring ges under vårdtiden. En förutsättning för detta är att intensivvårdssjuksköterskorna har förmågan att hantera alternativa bedömningsmetoder när patienten saknar möjlighet till att verbalt uttrycka sig kring sin smärta. Vidare hoppas författaren att studien kan bidra med att identifiera eventuella kunskapsluckor samt utgöra underlag för framtida förbättringsarbeten, som i sin tur kan stärka både patientsäkerhet och vårdkvalitet.

4.5 Förslag till fortsatt forskning

Författaren anser att det finns behov av fortsatt forskning inom området. Studier från flera intensivvårdsavdelningar och större urval skulle rekommenderas för att möjliggöra

överförbarhet av resultatet gentemot en större population, vilket skulle kunna uppnås genom exempelvis kvantitativ forskning. Detta skulle kunna bidra med att stärka evidensen om att smärtbedömning hos sederade respiratorvårdade patienter är en utmaning, samt att det finns behov av tydligare följsamhet till rutiner och utökad utbildning för intensivvårdssjuksköterskor. Detta i enlighet med resultatet från föreliggande studie. Ett annat förslag för framtida forskning som skulle vara intressant att studera är patienternas upplevelse av smärta och smärtlindring i samband med respiratorvård. Detta skulle kunna ge en mer fördjupad förståelse av smärtupplevelsen och utgöra underlag för vidare utveckling av smärtvård inom intensivvård.

4.6 Slutsats

Det finns en gemensam upplevelse hos intensivvårdssjuksköterskor att bedömning av smärta hos sederade respiratorvårdade patienter är komplext och svårt. Otillräcklig följsamhet till riktlinjer, rutiner och bedömningsinstrument i klinisk praxis medför att bedömningen i hög grad baseras på erfarenhet, anamnes, fysiologiska indikationer och uttryck hos patienten. Trots utmaningar i bedömning av smärta framkommer det i resultatet att intensivvårdssjuksköterskorna upplever att det finns ett välfungerande interprofessionellt samarbete, vilket skapar goda förutsättningar till att behandla smärta och på så sätt tillgodose patientens behov.

4.7 Användning av generativ AI

AI har använts som stöd under skrivprocessen för kontroll av stavning, grammatik och meningsuppbyggnad. Samtliga förslag från AI har granskats kritiskt och endast de justeringar som bedömts förbättra arbetet har tillämpats. Inget textinnehåll har kopierats direkt från AI.

5.0 Referenser

Almutairi, A. M., Pandaan, I. N., Alsufyani, A. M., Almutiri, D. R., Alhindi, A. A., & Alhusseinan, K. S. (2022). Managing patients' pain in the intensive care units: Nurses' awareness of pain management. *Saudi medical journal*, *43*(5), 514–521. https://doi.org/10.15537/smj.2022.43.5.20220169

Alotni, M., Guilhermino, M., Duff, J., & Sim, J. (2023). Barriers to nurse-led pain management for adult patients in intensive care units: An integrative review. *Australian critical care : official journal of the Confederation of Australian Critical Care Nurses*, *36*(5), 855–862. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2022.09.002

Arbour, C., & Gélinas, C. (2010). Are vital signs valid indicators for the assessment of pain in postoperative cardiac surgery ICU adults?. *Intensive & critical care nursing*, *26*(2), 83–90. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2009.11.003

Azevedo-Santos, I. F., & DeSantana, J. M. (2018). Pain measurement techniques: spotlight on mechanically ventilated patients. *Journal of pain research*, *11*, 2969–2980. https://doi.org/10.2147/JPR.S151169

Bhattacharyya, A., Laycock, H., Brett, S. J., Beatty, F., & Kemp, H. I. (2024). Health care professionals' experiences of pain management in the intensive care unit: a qualitative study. *Anaesthesia*, *79*(6), 611–626. https://doi.org/10.1111/anae.16209

Boncyk, C., Rolfsen, M. L., Richards, D., Stollings, J. L., Mart, M. F., Hughes, C. G., & Ely, E. W. (2024). Management of pain and sedation in the intensive care unit. *BMJ (Clinical research ed.)*, *387*, e079789. https://doi.org/10.1136/bmj-2024-079789

Buttes., Keal, G., Cronin, S. N., Stocks, L., & Stout, C. (2014). Validation of the critical-care pain observation tool in adult critically ill patients. *Dimensions of critical care nursing: DCCN*, 33(2). 78-81. https://doi.org/10.1097//DCC.0000000000000021

Correya, A., Rawson, H., Ockerby, C., & Hutchinson, A. M. (2025). Nurses' perceptions of patient pain, delirium, and sedation assessments in the intensive care

unit: A qualitative study. *Australian critical care : official journal of the Confederation of Australian Critical Care Nurses*, *38*(1), 101076. https://doi.org/10.1016/j.aucc.2024.05.013

Danel, J. K., Rosada-Kurasinska, J., Cpoik, M. M., Zdanowski, S., Gola, W., Misiolek, H., Bartkowska-Sniatkowska, A., & Bialka, S. (2025). Objective monitoring of acute pain and nociception i anasthesia and intensive care: evidence and applications. *Anesthesiology intensive therapy*, 57(1), 365-380. https://doi.org/10.5114/ait/213842

Deldar, K., Froutan, R., & Ebadi, A. (2018). Challenges faced by nurses in using pain assessment scale in patients unable to communicate: a qualitative study. *BMC nursing*, *17*, 11. https://doi.org/10.1186/s12912-018-0281-3

Docherty, C., McPeake, J., Quasim, T., MacTavish, P., Devine, H., O'Brien, P., Strachan, L., Lucie, P., Hogg, L., Sim, M., & Shaw, M. (2023). The relationship between pain, anxiety and depression in patients with post-intensive care syndrome. *Journal of critical care*, *78*, 154359. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2023.154359

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013) *Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden*. Lund: Studentlitteratur

Edberg, A.K, Wijk, H. (2019) *Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa.* Studentlitteratur AB.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse education today*, *24*(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Gulbrandsen, T. & Stubberud. D-G. (2009). *Intensivvård: Avancerad omvårdnad och behandling.* Lund: Studentlitteratur

Hamadeh, S., Lambert, G. W., Willetts, G., & Garvey, L. (2024). Pain management of adult sedated and ventilated patients in the intensive care units: A survey with free text

responses. *Intensive & critical care nursing*, *84*, 103770. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2024.103770

Hamdan, K. M., Shaheen, A. M., & Abdalrahim, M. S. (2022). Barriers and enablers of intensive care unit nurses' assessment and management of patients' pain. *Nursing in critical care*, *27*(4), 567–575. https://doi.org/10.1111/nicc.12624

Herr, K., Coyne, P. J., McCaffery, M., Manworren, R., & Merkel, S. (2011). Pain assessment in the patient unable to self-report: position statement with clinical practice recommendations. *Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses*, *12*(4), 230–250. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2011.10.002

Jamal, K., Alameri, R. A., Alqahtani, F.M., AlGarni, R. S., Alamari. N. A., Elshnawie, H. A., Badawi, S. E. A., & Hussien, A. M. (2023). Knowledge and Attitudes of Critical Care Nurses Regarding Pain Management in Saudi Arabia. *Medical archives (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina).* 77(1). 49-55. http://doi.org/10.5455/medarh.2023.77.49-55

Johnson, E., Heyns, T., & Nilsson, S. (2022). Nurses' perspectives on alternative communication strategies use in critical care units. *Nursing in critical care*, *27*(1), 120–129. https://doi.org/10.1111/nicc.12612

Kress, J. P., Pohlman, A. S., & Hall, J. B. (2002). Sedation and analgesia in the intensive care unit. *American journal of respiratory and critical care medicine.166(8).* 1024-1028. http://doi.org/10.1164/rccm.200204-270CC

Laycook H, Ward S, Halmshaw C, Nagy I, Bantel C. Pain in the intensive care: a personalized healthcare approach. *Journal of the Intensive Care Society* 2013: 14: 312-318.

Maatouk, H., Al Tassi, A., Fawaz, M. A., & Itani, M. S. (2019). Nurses' evaluation of critical care pain observation tool (CPOT) implementation for mechanically ventilated intensive care patients. *Data in brief*, *25*, 103997. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103997

Nazari, R., Froelicher, E. S., Nia, H. S., Hajihosseini, F., & Mousazadeh, N. (2022). Diagnostic Values of the Critical Care Pain Observation Tool and the Behavioral Pain Scale for Pain Assessment among Unconscious Patients: A Comparative Study. *Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine*, *26*(4), 472–476. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24154

Nordness, M. F., Hayhurst, C. J., & Pandharipande, P. (2021). Current Perspectives on the Assessment and Management of Pain in the Intensive Care Unit. *Journal of pain research*, *14*, 1733–1744. https://doi.org/10.2147/JPR.S256406

Nürnberg Damström, D., Saboonchi, F., Sackey, P. V., & Björling, G. (2011). A preliminary validation of the Swedish version of the Critical-Care Pain Observation Tool in adults. *Acta anaesthesiologica Scandinavica*, *55*(4), 379–386. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2010.02376.x

Polit, D. & Beck, C. (2021) *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice.* Philadelphia: Wolters Kluwer

Pota, V., Coppolino, F., Barbarisi, A., Passavanti, M. B., Aurilio, C., Sansone, P., & Pace, M. C. (2022). Pain in Intensive Care: A Narrative Review. *Pain and therapy*, *11*(2), 359–367. https://doi.org/10.1007/s40122-022-00366-0

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2021). Kompetensbeskrivning. *Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård.* https://swenurse.se/publikationer/kompetensbeskrivning-for-sjukskoterskor-inom-intensivvard

Rubulotta, F., Blanch Torra, L., Naidoo, K. D., Aboumarie, H. S., Mathivha, L. R., Asiri, A. Y., Sarlabous Uranga, L., & Soussi, S. (2024). Mechanical Ventilation, Past, Present, and Future. *Anesthesia and analgesia*, *138*(2), 308–325. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000006701

Sharma, S., Hashmi, M. F., & Valentino III, D. J. (2024). Sedation Vacation in the ICU. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

Shahiri T, S., & Gélinas, C. (2023). The Validity of Vital Signs for Pain Assessment in Critically Ill Adults: A Narrative Review. *Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses*, *24*(3), 318–328. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2023.01.004

Secunda, K. E., & Kruser, J. M. (2022). Patient-Centered and Family-Centered Care in the Intensive Care Unit. *Clinics in chest medicine*, *43*(3), 539–550. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2022.05.008

Shuaib, N. Nurses Knowledge Regarding Pain Management among Patients in Critical Care Units. JCAO. 2018:2:106.

Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (2024) *Riktlinjer för svensk intensivvård.* https://sfai.se/wp-content/uploads/2024/04/Riktlinjer-svensk-intensivvard-2024.pdf

Talebi, A., Ravari, A., Mirzaei, T., Moghadam Ahmadi, A., Zakeri, M. A., Hermis, A. H., & Al-Jabri, M. M. (2025). Effect of nurse's verbal communication on the level of consciousness, pain, and agitation in anesthetized patients admitted to the intensive care unit: a double-blind clinical trial. *BMC anesthesiology*, 25(1), 240. https://doi.org/10.1186/s12871-025-03071-5

Temesgen, N., Chekol, B., Tamirie, T., Eshetie, D., Simeneh, N., & Feleke, A. (2021). Adult sedation and analgesia in a resource limited intensive care unit - A Systematic Review and evidence based guideline. *Annals of medicine and surgery (2012)*, *66*, 102356. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102356

Thomas, D., Kuruppasseril, A. J., Samad, R. A., & George, E. J. (2025). Comparative Accuracy of Critical Care Pain Observation Tool (CPOT), Behavioral Pain Scale (BPS), and Non-verbal Pain Scale (NVPS) for Pain Assessment in Mechanically Ventilated Intensive Care Unit Patients: A Prospective Observational Study. *Indian journal of*

critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, *29*(6), 492–497. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24984

Vetenskapsrådet (2024) *God forskningsed* https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Vårdhandboken (2024). *Instrument för bedömning av smärta.* *https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/akut-bedomning-och-skattning/smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/instrument-for-bedomning-av-smarta/*

Weller, J. M., Mahajan, R., Fahey-Williams, K., & Webster, C. S. (2024). Teamwork matters: team situation awareness to build high-performing healthcare teams, a narrative review. *British journal of anaesthesia*, *132*(4), 771–778. https://doi.org/10.1016/j.bja.2023.12.035

Wiklund Gustin, L., Lindwall, L. (2012) *Omvårdnadsteorier i klinisk praxis.* Natur och kultur: Stockholm.

Wojnar-Gruszka, K., Sega, A., Płaszewska-Żywko, L., Wojtan, S., Potocka, M., & Kózka, M. (2022). Pain Assessment with the BPS and CCPOT Behavioral Pain Scales in Mechanically Ventilated Patients Requiring Analgesia and Sedation. *International journal of environmental research and public health*, *19*(17), 10894. https://doi.org/10.3390/ijerph191710894

Yaman Gülper, R., Reisli, R., Arıcan, Ş., Yosunkaya, A., & Tuncer Uzun, S. (2023). Comparison of pupillometer, critical care pain observation scale, and vital findings in the evaluation of pain in intensive care patients without oral communication. *The journal of the Turkish Society of Algology, 35*(2), 53–62. https://doi.org/10.14744/agri.2021.72246